

Skills abdomen

Table des matières

Général.....	1
1) Examen de l'abdomen.....	1
1.1) Marche à suivre.....	1
1.2) Théorie.....	5

Général

Dans cet examen, il est particulièrement important de mettre le patient le plus à l'aise possible, autrement il contractera sa musculature, sursautera, etc. et on ne sentira rien ! Du coup, ça vaut la peine de lui demander s'il n'aurait pas besoin d'aller aux toilettes pour uriner, de lui demander s'il a froid, de réchauffer le stéthoscope avant de toucher le patient avec, de réchauffer ses mains avant de toucher le patient, etc.

1) Examen de l'abdomen

Il faut faire attention au fait que l'ordre des examens est ici différent de l'ordre retrouvé dans les skills pulmonaire, cardiaque et des vaisseaux !

Comme dans tous les examens de l'ECOS de cette année, il est capital de toujours prévenir le patient de ce qu'on va faire (près de la moitié des points passent dans la communication !), d'expliquer à haute voix ce qu'on recherche et ce qu'on voit. Il faut aussi donner l'impression au patient qu'on est là que pour lui et qu'on ne s'occupe que de lui pour le bref instant pendant lequel on est avec lui.

Pour toutes les différentes parties de l'examen, on commencera toujours du côté opposé à l'endroit où le patient décrit une douleur. Pour la description du lieu de la douleur, ne pas hésiter à demander au patient de pointer du doigt l'endroit en question ou en tout cas de le délimiter avec son doigt si la douleur est diffuse, car on va essayer d'éviter de lui appuyer directement là où il a mal !

Il faut aussi bien tenir ses mains quand on ne fait rien avec.

On parle au patient et pas au ventre !

1.1) Marche à suivre

0) Entrée :

- Se désinfecter les mains
- Saluer le patient et se présenter
- Demander au patient la confirmation de son identité
- Expliquer la situation (= annoncer pourquoi on est là et quel examen on va faire) et demander l'accord du patient
- Demander au patient d'enlever son T-Shirt et de s'allonger en décubitus dorsal, les bras le long du corps, tout en étant totalement détendu (= position de base pour effectuer tout status). Typiquement, à l'ECOS, le patient ne prendra pas cette position !
Les femmes n'ont pas besoin d'enlever leur soutien-gorge pour cet examen.
Pour bien observer la région inguinale, il faut demander au patient de déboutonner le premier bouton de son pantalon et d'ouvrir sa ceinture

1) Inspection :

- **Demander au patient s'il a mal quelque part, que ce soit à l'abdomen ou aux reins**
- Visage
 - Signes de douleur
 - Signes de malaise
 - Respiration difficile
- Peau
 - Cicatrices ; on dit ce qu'on fait, on dit qu'on voit/ne voit rien et on demande la confirmation, car les cicatrices d'appendicites sont par exemple très discrètes !
 - Vergetures
 - Veines dilatées (caput medusae)
 - Lésions cutanées
 - Ictère
- Omphalique
 - Localisation
 - Aspect
 - Couleur
 - Hernie visible/voussure
- Allure de l'abdomen
 - Plat, bombé
 - Protubérant
 - Symétrique
- Mouvements
 - Respiratoires ; normal = par le ventre. Une respiration 'par les poumons' est typiquement une respiration de quelqu'un qui a mal
 - Péristaltiques
 - Pulsatiles

2) Auscultation ; redemander où le patient a mal et commencer par l'autre côté.

On indiquera les bruits qu'on perçoit suivant leur qualité (= tonalité) et quantité (= fréquence) (ex. : pour un iléus, on aura soit un 'Ping ping' très métallique arrivant avec une fréquence élevée (= lutte contre un obstacle), soit aucun bruit), en les qualifiant de normo-fréquents et normo-intenses.

Énoncer le fait que 'Je n'ai pas entendu de bruit suspect, donc tout à l'air normal'.

Il est pertinent de demander au patient s'il a mangé ou non avant le test, pour savoir si les bruits qu'on entend sont cohérents ou non avec la situation du patient :

- Écouter successivement les 4 quadrants abdominaux
 - On commence à l'opposé de l'endroit qui fait mal. Il faut bien appuyer le diaphragme du stéthoscope contre la peau pour entendre les bruits, qui devraient

être normalement des cliquetis et gargouillis, entre 5 et 34 fois par minute. On doit entendre un bruit dans chaque quadrant, et en l'absence de tout bruit, on peut gentiment pistonner l'endroit pour stimuler le péristaltisme

- Écouter le foyer aortique
 - On écoute le foyer aortique au milieu de l'abdomen (meilleur : péri-ombilical gauche), avec la cloche, à la recherche d'un quelconque souffle

3) Percussion (on ne percute pas ni la rate, ni les reins) :

- Percuter les 4 quadrants
 - On percute successivement les 4 quadrants à la recherche d'air (normal) dans le ventre (l'endroit douloureux étant toujours testé en dernier), indiqué par un tympanisme. En cas d'ascite, on demandera au patient de se mettre sur la gauche, puis la droite et de le percuter à chaque fois ; en effet, l'eau se déplacera avec la gravité, changeant les sons de la percussion !
- Rechercher le foie
 - On commence par percuter sous le mamelon, au niveau des poumons, puis on descend lentement. On devrait passer d'une sonorité à une matité, puis de la matité à un tympanisme. La percussion se fait le long de la ligne médio-claviculaire.
On peut aussi localiser le foie par la méthode du grattage, c'est-à-dire mettre son stéthoscope à l'endroit où se trouve le foie, puis gentiment gratter les alentours avec son doigt. Là où le foie est présent, on entend du bruit, et autre part non

4) Palpation ; on va ici rechercher des éventuelles résistances, signes par exemple de tumeur, ou alors naturellement de la présence du foie, des reins, de la vessie, de ganglions inguinaux, de selles dures, du côlon sigmoïde, de la vessie, etc.

Pendant la palpation, on va également rechercher les signes d'un péritonisme (= irritation péritonéale), en le localisant avec la palpation superficielle, puis en le confirmant par une douleur lors de la décompression brusque/détente :

- Palper superficiellement les 4 quadrants en regardant l'expression du patient
 - **Se fait à une main**, le quadrant douloureux en dernier. Elle sert à lever la résistance musculaire, identifier les structures superficielles et les masses et à localiser la douleur.
Pour la technique, il suffit de mettre 3 ou 4 doigts de sa main sur le ventre et de gentiment masser
- Palper profondément les 4 quadrants en regardant l'expression du patient
 - **Se fait à deux mains**, le quadrant douloureux en dernier. Pour toute masse qui serait repérée, il faut en préciser la localisation, la forme, la taille (faire des analogies ; ex. : comme une pièce de 1 fr, etc.), la surface, les contours (diffus ou précis), la consistance, la sensibilité (= douleur ou pas douleur), la mobilité et la pulsation.
Pour la technique, on met les mains les unes sur les autres, une explorant et l'autre poussant et on explore avec les doigts. On masse comme pour le superficiel et on descend gentiment de superficiel à profond
- Défense/détente dans les 4 quadrants

- On enfonce lentement et assez profondément une de ses mains dans un des quadrants et on demande si le patient à mal. On va ensuite retirer rapidement sa main et redemande si le patient à mal
- Recherche d'une appendicite
 - Signe de McBurney : on localise l'appendicite antérieure en pointant le tiers inférieur d'une ligne imaginaire tracée entre l'ombilic et l'épine iliaque antéro-supérieure
 - Signe du psoas : on localise l'appendicite postérieure en demandant au patient allonger d'essayer d'élever sa cuisse (tendue et complètement droite) contre résistance (douleur lancante dans le bas du dos)

5) Examen spécifique du foie, de la rate, des reins et de l'aorte

- Foie
 - Estimer sa taille, sa forme, sa sensibilité et sa consistance.
On le palpe avec la main droite (en dehors du m. grand droit), la gauche étant derrière les 11 à 12ème côtes pour soulever le foie.
On peut également palper le foie à deux mains, en formant un 'front' avec les deux mains, puis en allant explorer la zone sous le rebord costal.
Comme on ne sait pas si le patient a une hépatomégalie, dans les deux types de palpation, on commence depuis ~ l'ombilic, puis on remonte. Si on a de la peine à sentir le foie (et surtout pour les patients obèses), on peut demander au patient d'inspirer profondément (= le diaphragme pousse le foie) ou utiliser la 'technique du crochet' (= se mettre vers la tête du patient et lui attraper les côtes)
 - Signe de Murphy : dans le but de détecter une affection de la vésicule biliaire (majoritairement des cholécystites), on demande au patient d'inspirer, on positionne ses deux mains sous le rebord costal, puis on demande au patient d'expirer pour nous permettre d'enfoncer les mains, et finalement on lui demande de réinspirer, ce qui devrait faire très mal, car l'inspiration pousse le foie (et la vésicule biliaire !) sur nos doigts
- Rate (on ne la percute pas)
 - On positionne sa main gauche derrière les côtes du patient pour pousser la rate vers le haut et on essaie de la palper avec la main droite, sous le rebord costal ; on demande finalement au patient d'inspirer profondément. Normalement, on ne devrait rien sentir, sauf chez les patients très maigres ou avec une splénomégalie, qui fait descendre la rate vers le bas à droite
- Reins
 - On essaie de les palper juste après la rate, en utilisant la même technique toujours avec la main gauche qui surélève les côtes et la main droite qui palpe. On ne devrait pouvoir les palper que si leur taille est augmentée
 - On demande au patient de s'asseoir, puis on se positionne derrière lui. On peut lui redemander s'il aurait une douleur dans le dos, vers le bas des côtes, puis on lui annonce qu'on va percuter. Pour ce faire, on positionne sa main gauche (~ niveau de la 12ème côte) comme enclume (en soulevant légèrement les côtes) sur un des reins du patient et on tape modérément comme pour casser des noix. La moindre vibration devrait le faire sauter au plafond s'il a une pyélonéphrite

- Aorte
 - Appuyer fermement sur la partie supérieure de l'abdomen, légèrement à gauche (peut se faire à une ou deux mains, mais à deux mains c'est plus facile). On devrait sentir une petite pulsation ou rien du tout (chez les gens maigres on sent cette pulsation assez fort)

6) Orifices herniaires :

- Observer les régions abdominale et crurale à la recherche de voussures
 - On a 5 orifices herniaires possibles : épigastrique (fréquent), ombilical (très fréquent), inguinal, fémoral et cicatriciel.
On essaie premièrement de trouver la présence de hernies à l'oeil nu, les 5 hernies possibles pouvant être facilement visibles.
Pour détecter la hernie ombilicale, on met un doigt dans le nombril du patient, puis on lui demande de relever la tête. Si quelque chose essaie de sortir, c'est un alien.
Pour la hernie inguinale, on demande simplement au patient de relever la tête et on observe la région inguinale. On peut aussi suivre le cordon spermatique avec son doigt et demander au patient de tousser

7) Toucher rectal : on finit avec 'J'ai terminé l'examen de l'abdomen et je transmettrai toutes les informations au Dr. X. Je vais maintenant me référer à mon chef, mais je pense qu'un toucher rectal serait pertinent'

1.2) Théorie

Pour l'examen, on divise l'abdomen en 4 quadrants, mais une localisation précise pour une douleur devra utiliser le découpage en 9 cadrans (hypochondres (droit et gauche), épigastre, flancs (droit et gauche), région ombilicale, fosses iliaques (droite et gauche) et sus-pubienne/hypogastre), plus précis.

Conditions générales : il faut un bon éclairage, le patient doit être détendu, l'abdomen est complètement mis à nu (et on dégage les régions inguinales en faisant ouvrir la ceinture et en ouvrant un bouton) et la vessie du patient doit être vide (on pousse fort sur l'abdomen). Les mains de l'examineur doivent être chaudes, ses ongles courts.

Le patient doit être couché confortablement sur le dos, avec un coussin sous la tête et les bras le long du corps. Il est important d'expliquer et de prévenir le patient de toutes les manipulations !

Palpation :

- Le foie est difficile à palper, situé à l'arrière des côtes et faisant entre 6cm et 12cm de haut
- La **rate et les reins** (se trouvent entre les côtes 11 et 12) ne sont **normalement pas palpable du tout**, mais on les palpe pour rechercher une anomalie éventuelle
- On fait passer la palpation en dernier, car si on commence directement par la palpation, on risque d'activer le transit et de biaiser l'auscultation et les bruits entendus
- Si le patient est tendu, on peut lui demander d'expirer pendant qu'on palpe ou encore lui demander de respirer par la bouche, avec la mâchoire tombante